

LAVADO GÁSTRICO

Rubén Pérez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El lavado gástrico consiste en un procedimiento en el que se retira una sustancia potencialmente tóxica, previamente ingerida, de la cavidad gástrica.

No se trata de un procedimiento rutinario y se debe reservar para aquellos casos en los que exista una situación de emergencia vital en la que el intervalo ingesta-lavado gástrico no supere los 60 minutos. Se sugiere reservarlo para situaciones no susceptibles de manejo con carbón activado o antídotos y en centros con experiencia suficiente para realizarlo con seguridad.

INDICACIONES

Las indicaciones principales son ingesta de:

Sustancias neutralizables (consultar previamente con toxicólogo o centro de referencia)

- Formaldehído
- Fluoruro
- Yodo
- Hierro
- Ácido Oxálico

Sustancias con alta morbi-mortalidad

- Beta-bloqueantes
- Bloqueadores canales de calcio
- Cloroquina
- Cianuro
- Metales pesados
- Antidepresivos heterocíclicos

Sustancias pobremente absorbidas por carbón activado

- Litio
- Metales pesados
- Alcohol a niveles tóxicos

Sustancias que formen concreciones

- Preparaciones de liberación sostenida o cubierta entérica.
- Fenotiazinas
- Salicilatos

• Sustancias que no posean antídoto

- Colchicina
- Paraquat
- Ácido selenioso

CONTRAINDICACIONES

- Ingesta de sustancias cáusticas (riesgo perforación).
- Convulsiones incontrolables (riesgo aspiración y lesión).
- Anatomía faringoesofágica alterada.
- Partículas gran tamaño (setas).
- Presencia o sospecha de cuerpo extraño.
- Ingesta no tóxica o mínimamente tóxica.
- Ingesta de productos destilados del petróleo de baja viscosidad (gasolina, queroseno...)
- Depresión del SNC o disminución de reflejo de la vía aérea en ausencia de medidas protectoras de la misma.
- Retraso en la asistencia (>1 hora post-ingesta).
- Hemesis o hematemesis severa.
- Arritmias cardíacas significativas o coagulopatía.
- Ámbito pediátrico (relativa).

TÉCNICAS Y MATERIAL A UTILIZAR

Dispondremos de: sonda orogástrica (32-50 Fr, calibre superior a SNG) o tubo de SNG en su defecto perforando extremo distal, guantes, bata desechable, mascarilla, lubricante, anestésico tópico (opcional), jeringa de 50cc adaptable al conector en Y, conector en Y adaptable al tubo de inserción, embudo, batea, 3L de suero salino 0,9% a temperatura corporal y mordedor (si inserción orogástrica).

* Dos sistemas: abiertos (el que describiremos) y cerrado (kits comerciales).

Preparación del procedimiento:

- Informar al paciente (si consciente), solicitando consentimiento y colaboración.
- Realizar lavado adecuado de manos y posteriormente utilizar medidas protección (riesgo epistaxis): bata, mascarilla y guantes desechables.
- Colocar posición Fowler (cabecero 45-60°).
- Retirar prótesis dentales de existir.
- Estimar la longitud de la sonda NG (ver capítulo SNG).
- Comprobar permeabilidad de narinas/cavidad oral.
- Aplicar anestésico tópico (opcional).
- Lubricar extremo distal de la sonda.
- A) Inserción Orogastrica (elección): realizar flexión cervical, insertar mordedor para prevención de mordeduras, inserción digital del tubo hasta situarlo entre los dedos 2º y 3º que se ubican a nivel de orofaringe y deprimen lengua. Introducir de forma suave el tubo a lo largo del esófago.
- Inserción Nasogástrica (ver capítulo SNG).
- Colocar al paciente en Trendelenburg izquierdo (en decúbito lateral izquierda con cabeza en plano inferior respecto a la cintura).
- Comprobar inserción adecuada (ver capítulo SNG).
- Conectar sonda al conector en Y, con rama aferente (conectada a Suero) y eferente (drenaje).

Procedimiento: (*Nos referimos al sistema abierto):

- Clampar la rama eferente.
- Instilar 50-100mL (SS FF 0,9%) con jeringa en rama aferente y clamparla.

- Abrir rama eferente para permitir salida del contenido y en caso de no drenaje espontáneo realizar aspirado con jeringa y suave masaje a nivel de epigastrio.
- Continuar hasta irrigar con un total de 3L (salvo aparición o sospecha de complicaciones) y el contenido drenado sea claro.
- En caso de necesidad administrar carbón activado a través de la sonda.
- Al finalizar clampar la sonda para retirada.

Importante

- Intervalo ingesta-lavado importa: realizado a los...
 - 5 min. postingesta: 90% recuperación sustancia.
 - 10 min. postingesta: 45% recuperación sustancia.
 - 19 min. postingesta: 30% recuperación sustancia.
 - 60 min. postingesta: 8% recuperación sustancia.
- Más efectivo en: ingesta de múltiples comprimidos pequeños o líquidos que en ingesta de comprimidos de gran tamaño.
- Depresión de SNC o convulsiones controladas: realizable si colocamos previamente tubo endotraqueal.

COMPLICACIONES

- Depresión respiratoria.
- Neumonitis aspirativa.
- Arrítmicas cardíacas (aumento del tono vagal).
- Laceración gastroesofágica.
- Perforación gastroesofágica.
- Laringoespasma.
- Mediastinitis.

No olvidar

- Se realizan lavados intermitentes con cantidades en torno a 50-100mL: cantidades mayores facilitan el paso de la toxina hacia el píloro.
- La técnica puede ser utilizada para administrar carbón activado.
- No realizar si retraso en procedimiento tras la ingesta >1 hora.

BIBLIOGRAFÍA

- Banner W, Pentel PR. Medical Toxicology [Internet]. 1st ed. Vol. 271, JAMA: The Journal of the American Medical Association. Elsevier Ltd.; 1994. 1681-1682 p.
- Krenzelok EP, Leikin JB. Approach to the poisoned patient. Disease-a-Month. 1996;42(9):514–607.
- Zeringue M, Fowler GC. GASTROINTESTINAL DECONTAMINATION. 2018;1385–91.- Origüen Sabater J. De Miguel B. (2012). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre, pp.1262-1263.